UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH UNIVERSITÉ **RECONNUE PAR L'ÉTAT** جامعة معترف بها من طرف الدولة	**Année universitaire : 2023-2024** **Niveau : 4ème année** **Examens Session Normale (Mai 2024)**	FPMM FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH
Semestre : S8	**Module : Appareil locomoteur** **Durée : 01 Heure** **Enseignant : Pr. Niamane (Coordinateur)**	

TRAUMATO-ORTHOPEDIE : 1 à 20 – RHUMATOLOGIE : 21 à 40 - MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION : 41 à 50.

1 - Toutes les propositions suivantes répondent aux principes du traitement des fractures de l'extrémité inferieure du fémur sauf deux lesquelles ?

A. C'est une urgence thérapeutique
B. Chercher une contention solide
C. Chercher une mobilisation précoce
D. Chercher une mobilisation tardive
E. Chercher une contention souple

2 - La triade diagnostique d'une tendinopathie comporte :

A. Douleur à la palpation du tendon
B. Douleur musculaire
C. Douleur à l'étirement du tendon
D. Douleur à la contraction résistée
E. Aucune réponse juste

3- La fracture de Hoffa :
A. Est une fracture du radius distal
B. Est une fracture unicondylienne du fémur distal
C. Est une fracture à trait frontal
D. Est une fracture de la palette humérale
E. Passe souvent inaperçue sur une radiographie du genou de face

4- Parmi ces tests lesquels explorent les lésions méniscales :
A. Le test de Skinner
B. Le scotch test
C. Le grinding test d'Appley
D. Le test de NEER
E. Le test de Brunet Guedj

5- La technopathie se définit par :
A. La pathologie du tendon d'Achille
B. La pathologie due à la technique du geste sportif
C. La pathologie rhumatismale du sportif
D. La pathologie endocrinienne du sportif
E. Aucune réponse juste

6- La présence d'un trait de fracture vertical sur la malléole médiale et sous ligamentaire sur la malléole latérale au cours d'une fracture bimalléolaire présume que le mécanisme est en :

A. Adduction
B. Abduction
C. Flexion plantaire
D. Flexion dorsale
E. Aucune réponse juste

7- Les signes de gravité d'une lésion musculaire sont :

A. La perception d'un craquement
B. L'impotence fonctionnelle totale objective et immédiate
C. L'installation rapide de l'œdème
D. La reprise rapide du sport
E. Aucune réponse juste

8 - Devant une luxation du genou il faut rechercher impérativement :

A. Une lésion du nerf crural
B. Une fracture de Hoffa
C. Une lésion de l'artère poplitée
D. Une rupture du tendon calcanéen
E. Aucune réponse n'est juste

9 - Parmi ces examens paracliniques, lequel est le plus sensible pour poser le diagnostic d'une fracture de fatigue :

A. Radiographie standard
B. Échographie
C. IRM
D. Arthrographie
E. Tomographie

10 – L'avalement de la tubérosité tibiale antérieure du genou (recul de la TTA) témoigne de la lésion du :

A. Ligament poplité
B. Ligament latéral interne
C. Ligament croisé antéro latéral
D. Ligament croisé postéro médial
E. Aucune réponse juste

11- La présence d'un tiroir antérieur à l'examen clinique du genou témoigne d'une lésion du :

A. Ligament poplité
B. Ligament latéral interne
C. Ligament croisé antéro latéral
D. Ligament croisé postéro médial
E. Aucune réponse juste

12-Un patient âgé de 75 ans présente suite à une chute de sa hauteur un traumatisme de la hanche droite occasionnant douleur et impotence fonctionnelle. Les deux diagnostics les plus probables sont :

A. Fracture du col du fémur
B. Fracture du rachis lombaire
C. Fracture du massif trochantérien
D. Fracture de rein
E. Aucune réponse juste

13-Le patient n'arrive pas à décoller son talent du plan du lit. Ce signe clinique s'appelle :

A. Le signe talo-crural
B. Le signe du glaçon
C. La talalgie
D. Le signe clino-statique
E. Aucune réponse juste

14- La palpation révèle une douleur du pli de l'aine et un massif trochantérien indolore. Le diagnostic le plus probable est :

A. Fracture du col du fémur
B. Fracture du rachis lombaire
C. Fracture du massif trochantérien
D. Fracture de rein
E. Aucune réponse juste

15 - Les fractures du massif trochantérien engagent le pronostic vital du patient de par : 1 réponse juste

A. Le caractère douloureux de ces fractures
B. Le caractère fréquemment ouvert de ces traumatismes
C. Le caractère très hémorragique de ces fractures
D. Les complications de décubitus
E. Aucune réponse juste

16 – Les objectifs du traitement des fractures du massif trochantérien sont :

A. Verticaliser rapidement le patient
B. Sauver la vie du patient
C. Éviter les complications de ces fractures
D. Préconiser un alitement prolongé du patient
E. Aucune réponse juste

17 –L'élément clinique le plus évocateur d'une fracture du scaphoïde carpien est:

A. Douleur à la pression de la styloïde radiale
B. Signe de Tinel positif
C. Signe de Thompson positif
D. Douleur à la pression de la tabatière anatomique
E. Aucune réponse juste

18 - Les repères normaux à l'examen du coude sont :

A. Ligne horizontale de Hunter à l'extension du coude
B. Ligne de Nelaton à l'extension du coude
C. Triangle de Nelaton à la flexion du coude
D. Triangle de Hunter à la flexion du coude
E. Aucune réponse juste

19 – La déformation caractéristique de la fracture de Pouteau Colles est :

A. Main tombante en col de cygne
B. Déformation du poignet en dos de fourchette
C. Déformation en baillonnette
D. Déformation en main botte radiale
E. Aucune réponse juste

20 – Lors d'une fracture de la diaphyse humérale l'une des complications immédiates est recherchée systématiquement :

A. Lésion de l'artere radiale
B. Lésion du nerf médian
C. Lésion du nerf ulnaire
D. Lésion du nerf radial
E. Aucune réponse juste

21-Le liquide articulaire dans la gonarthrose a la (les) propriété(s) suivante(s) ?

A. Peut être à l'origine d'un choc rotulien
B. Aseptique
C. Un nombre d'éléments blancs >2000 éléments/mm3
D. Riche en micro-cristaux d'urate de sodium
E. Visqueux, jaune citrin

22-Les manœuvres qui mettent en évidence la présence d'un conflit sous acromial sont :

A. La manœuvre de Neer.
B. La manœuvre de Patte.
C. La manœuvre de Jobe.
D. La manœuvre de Yokum.
E. La manœuvre de Thompson.

23- Une patiente âgée de 60 ans, diabétique de type 2, consulte pour une douleur de l'épaule droite. La patiente est apyrétique. L'examen de l'épaule montre une limitation douloureuse des mouvements actifs et passifs. Quel diagnostic faut-il évoquer ?

A. Arthrite septique de l'épaule
B. Métastases osseuses
C. Polyarthrite rhumatoïde
D. Chondrocalcinose articulaire
E. Une capsulite rétractile

24-Parmi les étiologies des coxites chroniques, on retient :

A. La synovite villo-nodullaire.
B. L'algodystrophie de la hanche.
C. La spondyloarthrite.
D. La coxarthrose.
E. L'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale.

25-Un chauffeur de 40 ans, consulte pour une douleur lombaire apparue à la suite du port d'une charge lourde, il y a 15 jours. Quels sont les éléments à écarter pour retenir le diagnostic de lombalgie commune ?

A. L'horaire inflammatoire de la douleur.
B. La présence de la fièvre.
C. Des épisodes similaires dans ses antécédents
D. L'altération de l'état général.
E. Un antécédent récent de néoplasie.

26-Un homme de 65 ans, qui fait une crise de goutte de la cheville. Que montre l'analyse cytologique du liquide de ponction articulaire de la cheville ?

A. La présence de germes dans le liquide synovial
B. La présence de microcristaux de pyrophosphate de calcium.
C. Un nombre d'éléments blancs > 5000 éléments/mm3
D. La présence de microcristaux d'urate de sodium
E. Un nombre d'éléments blancs < 500 éléments/mm3

27-Parmi les signes radiologiques suivants, lequel est pathognomonique de l'ostéomalacie carentielle :

A. Stries de Looser Milkmann
B. Hypertransparence osseuse diffuse
C. Lyse de la corticale
D. Fractures pathologiques
E. Déformations osseuses

28-En cas d'ostéomalacie par carence en vitamine D :

A. La calcémie est basse.
B. La calciurie est élevée.
C. La phosphorémie est élevée.
D. La phosphorémie est basse.
E. Les phosphatases alcalines sont élevées.

29-La lésion le plus souvent trouvée à l'origine de l'hyperparathyroïdie primaire est :

A. Un cancer parathyroïdien
B. Un adénome bénin
C. Une hyperplasie des parathyroïdes
D. Une tumeur hypophysaire bénigne
E. Aucune des propositions

30-L'algodystrophie à la phase chaude se manifeste par :

A. Une douleur articulaire et péri-articulaire régionale.
B. Des troubles vaso-moteurs.
C. Une allodynie.
D. Des rétractions capsulo-ligamentaires.
E. Des troubles cutanés trophiques.

31-Quel est le signe radiologique en faveur de l'algodystrophie :

A. Le pincement de l'interligne articulaire
B. Une condensation osseuse
C. Une lyse de la corticale
D. Erosions
E. Hypertransparence osseuse mouchetée

32-Concernant le syndrome du canal carpien :

A. Peut révéler une polyarthrite rhumatoïde.
B. La forme sensitive est la plus fréquente.
C. Le signe de TINEL reproduit les symptômes par la flexion forcée du poignet pendant 30 à 60 secondes.
D. L'EMG peut être normal.
E. Le traitement nécessite parfois une infiltration de corticoïdes.

33-Une patiente de 55 ans se présente avec un syndrome du canal carpien. Elle a une amyotrophie des muscles thénariens et une anesthésie de la pulpe du pouce, de l'index et du médius. La thérapeutique la plus appropriée à proposer est :

A. Repos par orthèse et surveillance EMG.
B. Infiltration de corticoïdes locaux.
C. Traitement chirurgical.
D. Anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie générale.
E. Rééducation.

34-La cause habituelle des tendinopathies est :

A. Les infections
B. Les tumeurs
C. Les micro-traumatismes
D. Certains médicaments.
E. Les ténosynovites à corps étranger

35-Chez un patient qui vient consulter pour une arthrose, on peut trouver les éléments suivants :

A. Une douleur mécanique.
B. Une déformation articulaire.
C. Des signes inflammatoires locaux.
D. Une boiterie
E. Un retentissement sur l'état général

36-Une patiente consulte chez vous, et vous posez le diagnostic de radiculalgie des membres inférieurs symptomatiques. Noter parmi les énoncés suivants ceux qui vous orientent vers ce diagnostic :

A. La douleur est inflammatoire.
B. La douleur est calmée par le repos.
C. La douleur est pluri radiculaire.
D. Il existe une fièvre qui accompagne la douleur.
E. A l'imagerie il existe une hernie discale à l'étage L4L5.

37-Dans le syndrome pelvien de la spondyloarthrite on a :

A. Une talalgie plantaire inflammatoire.
B. Une fessalgie inflammatoire.
C. Une douleur inflammatoire de la paroi thoracique.
D. Une lombo-sciatique tronquée (Pseudo-sciatique) inflammatoire.
E. Une uvéite.

38-La radiculalgie L 4 à le trajet suivant :

A. Débute sur le pli de l'aine puis descend dans la face antérieure de cuisse puis sur le bord interne de la cuisse.
B. Débute sur la fesse puis descend dans la face antéro externe cuisse puis sur le bord antérieur de la jambe.
C. Débute sur l'abdomen puis descend dans la face antérieure de la cuisse.
D. Débute sur le genou puis descend dans la face antéro externe de la jambe.
E. Débute sur la face postérieure de la cuisse puis descend dans la face postérieure de la jambe pour se terminer sur 5ème orteil.

39-La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire caractérisé par :

A. Une atteinte axiale (du rachis).
B. Une atteinte asymétrique des articulations.
C. L'absence de syndrome inflammatoire biologique.
D. Une atteinte du tissu conjonctif prédominante sur la synoviale.
E. L'absence de déformation dans la forme évoluée.

40-Dans la polyarthrite rhumatoïde la lésion élémentaire initiale est :

A. L'enthésite.
B. La synovite
C. L'ostéite
D. La fissure osseuse.
E. Le pincement du cartilage

Une patiente de 37 ans souffre d'une entorse de la cheville droite. (Cas clinique avec 5 questions)

41-Les déficiences possibles chez cette patiente sont :

A. Aller au travail
B. La difficulté à marcher
C. La difficulté à monter et descendre les escaliers
D. La douleur
E. Pratiquer du sport

42-Les limitations d'activité possibles chez cette patiente :

A. L'épanchement articulaire
B. La difficulté à aller au travail
C. La difficulté à faire ces courses
D. La difficulté à marcher
E. La difficulté à pratiquer du sport

43-Les restrictions de participation possible chez cette patiente :

A. La difficulté à descendre les escaliers
B. La difficulté à monter les escaliers
C. La difficulté à promener son chien
D. La limitation articulaire
E. Le craquement articulaire

44-Pour complément de prise en charge, vous adresser cette patiente chez :

A. Le kinésithérapeute
B. L'ergothérapeute
C. L'orthophoniste
D. Le podologue
E. L'orthoprothésiste

45-Vous prescrivez une canne simple. Que conseillez-vous ?

A. Adaptation de la hauteur de la canne.
B. L'associer à la rééducation.
C. Sevrage progressive
D. Utilisation de la canne du coté controlatérale donc à gauche.
E. Utilisation de la canne du coté homolatérale donc à droite.

46-Parmi les propositions suivantes, laquelle constitue un facteur de risque de lésion musculaire ?

A. Echauffement
B. Entrainement
C. Erreurs diététiques
D. L'étirement musculaire
E. L'hydratation

47-La paralysie cérébrale :
A. Empêche toute scolarité
B. Est due à des lésions du cerveau adulte
C. Est la principale cause de handicap moteur de l'enfant
D. Peut mener à une situation de polyhandicap
E. Peut-être prévenue

48-La démarche cérébelleuse est caractérisée par :
A. Des pas irréguliers
B. Un élargissement du polygone de sustentation
C. Un fauchage
D. Un steppage
E. Une marche à petits pas

49-Un joueur de foot est victime d'un traumatisme musculaire au cours d'un match. Quels sont les principes de votre prise en charge immédiate :

A. Vous appliquez du froid
B. Vous appliquez aussi un anti-inflammatoire local sur le muscle
C. Vous appliquez une compression sur le muscle
D. Vous déchargez le membre atteint
E. Vous lui conseillez d'arrêter momentanément l'activité sportive

50-Concernant les prothèses :

A. L'emboîture est faite sur mesure.
B. Leur bon usage nécessite une rééducation associée et adaptée.
C. Peuvent être internes ou externes
D. Sont fabriquées par les podologues
E. Sujettes à une prescription spécialisée.

Code candidat

Nom

Prénom

CORRECTION

Remarques :

Université Privée de Marrakech
Faculté Privée de Médecine de Marrakech

Année Universitaire : 2023-2024

L'appareil locomoteur 2023-2024

L'appareil locomoteur
Pr Niamane Radouane

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☒	☒
Q2	☒	☐	☒	☒	☐
Q3	☐	☒	☒	☐	☒
Q4	☐	☐	☒	☐	☒
Q5	☐	☒	☐	☐	☐
Q6	☒	☐	☐	☐	☐
Q7	☒	☒	☒	☐	☐
Q8	☐	☐	☒	☐	☐
Q9	☐	☐	☒	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☒	☐
Q11	☐	☐	☒	☐	☐
Q12	☒	☐	☒	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☒	☐
Q14	☒	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☒	☐
Q16	☒	☒	☒	☐	☐
Q17	☐	☐	☐	☒	☐
Q18	☒	☐	☒	☐	☐
Q19	☐	☒	☐	☐	☐
Q20	☐	☐	☐	☒	☐
Q21	☒	☒	☐	☐	☒
Q22	☒	☐	☐	☒	☐
Q23	☐	☐	☐	☐	☒
Q24	☐	☐	☒	☐	☐
Q25	☒	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q26	☐	☐	☒	☒	☐
Q27	☒	☐	☐	☐	☐
Q28	☒	☐	☐	☒	☒
Q29	☐	☒	☐	☐	☐
Q30	☒	☒	☒	☐	☐
Q31	☐	☐	☐	☐	☒
Q32	☒	☒	☐	☒	☒
Q33	☐	☐	☒	☐	☐
Q34	☐	☐	☒	☐	☐
Q35	☒	☒	☐	☒	☐
Q36	☒	☐	☒	☒	☐
Q37	☐	☒	☐	☒	☐
Q38	☐	☒	☐	☐	☐
Q39	☐	☐	☐	☒	☐
Q40	☐	☒	☐	☐	☐
Q41	☐	☐	☐	☒	☐
Q42	☐	☐	☐	☒	☐
Q43	☐	☐	☒	☐	☐
Q44	☒	☐	☐	☐	☐
Q45	☒	☒	☒	☒	☐
Q46	☐	☐	☒	☐	☐
Q47	☐	☐	☒	☒	☒
Q48	☒	☒	☐	☐	☐
Q49	☒	☐	☒	☒	☒
Q50	☒	☒	☒	☐	☒